RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 1 Y 2

Ciencias de la Ocupación

Todas las lecturas de los dos módulos: bases históricas y filosóficas, los períodos de Bing, el concepto de ocupación, los paradigmas, los antecedentes de la TO (también en Argentina), la TO basada en la CO, sus aplicaciones y los modelos de diversidad funcional. Con cuadros, líneas de tiempo, comparaciones y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

LA IDEA QUE ATRAVIESA TODO

La **ciencia de la ocupación (CO)** aparece formalmente en el **siglo XX**, pero la "ocupación" se usaba antes como **estrategia terapéutica** para trastornos mentales y dolencias físicas. Sirve para entender el entramado teórico y práctico de la **terapia ocupacional (TO)**, desde sus inicios hasta hoy.

OJO CON LAS SIGLAS

CO = ciencia de la ocupación (disciplina académica). **TO** = terapia ocupacional (profesión). **AOTA** = Asociación Americana de TO. **USC** = Universidad del Sur de California. **TGS** = teoría general de sistemas. **MVI** = Movimiento de Vida Independiente.

U1 Bases históricas, epistemológicas y filosóficas de la CO

La historia de la CO está **fuertemente ligada a la historia de la humanidad**: se fue desarrollando junto con los hitos históricos que cambiaron decisiones y direcciones hasta llegar a lo que hoy conocemos.

DEFINICIÓN DE OCUPACIÓN (TOWNSEND, 1997)

"El **proceso activo de vivir**, desde el comienzo hasta el final de la vida. Nuestras ocupaciones son todos los procesos activos para **cuidar** de nuestras personas y de los otros; **disfrutar** la vida; y ser social y económicamente **productivos** durante toda la vida y en distintos contextos." Es una de las **primeras definiciones** con que se empieza a implantar la idea de una CO.

La premisa fundante

Susan Tracy y Eleanor Clark (precursoras de la profesión): la **participación en ocupaciones es importante para la salud**. Sobre esta base se desarrolla la base teórica de la disciplina (Morrison et al., 2000).

¿Qué influyó en su desarrollo?

Condiciones variadas y con **poca relación con la salud y el trabajo**: la **industrialización**, los **derechos de la mujer**, las **guerras**, los **recesos económicos**, la **legislación de salud** y la **era digital**.

FRASE DE EXAMEN

Este proceso demuestra que el desarrollo del conocimiento **no se da en forma lineal, lógica, ininterrumpida y predecible**: se gesta según el contexto que atraviesa a la humanidad.

1.1 Precursores de la CO por período

Período	Quién	Aporte
Prehistórico 1700-1899	John Locke (médico y filósofo)	Adelantó ideas y prácticas de la CO: **aprendizaje sensorial** y **pragmatismo**.
Prehistórico	Philippe Pinel (asilos Bicêtre y Salpêtrière)	Inició la **humanización de los asilos**; pionero del trato humanitario a enfermos mentales; **precursor** del tratamiento moral.
Prehistórico	William Tuke (empresario y filántropo inglés)	**Padre del movimiento del tratamiento moral**: trato compasivo, eliminó penitencias y castigos físicos, mejoró condiciones para la autoestima.
1900-1919	Clifford Beers (empresario)	Escrito crítico sobre los asilos, *Una mente que se encontró a sí misma* (1908) → creó el **movimiento de salud mental**.
1900-1919	Abraham Flexner	Reforma de la **educación médica**: más investigación, pero se dejaron de lado factores sociales, psicológicos y espirituales.
1900-1919	Adolf Meyer (psiquiatra)	Introdujo un **enfoque individual** de la terapia en EE. UU.
1900-1919	Elwood Worcester (movimiento manuelista)	Tratamiento **holístico, centrado en el paciente y comunitario** para indigentes con tuberculosis; involucró servicios sociales.
1900-1919	Herbert J. Hall (médico)	Trató la **neurastenia** con participación activa en oficios y artesanías: **cura a través del trabajo**.
1900-1919	William Rush Dunton Jr.	Inspirado en Hall, diseñó en **1912** programas en ocupaciones; **líder del desarrollo de la TO**.

Período	Quién	Aporte
1900-1919	Eleanor Clarke Slagle (estudiante de trabajo social)	Aplicó el curso *Ocupaciones y Recreaciones Curativas* en instituciones mentales → programa de **ocupaciones curativas**.
1900-1919	George Edward Barton · Thomas B. Kinder	Barton: desde su recuperación (tuberculosis y parálisis histérica) impulsó la **cura del trabajo**. Kinder (arquitecto): **rehabilitación vocacional** de heridos de la 1.ª Guerra.
1920-1939	Dunton · Meyer	Dunton preside la **National Occupational Therapy Society** y estandariza la educación. Meyer: **psicobiología**, la enfermedad mental refleja la **desorganización de los hábitos** → organizar el tiempo equilibrando quehacer y descanso.
1920-1939	Frank H. Krusen · Kinder	Krusen: fusión de TO y **terapia física** en la rehabilitación. Kinder (director de Salud Pública): TO + **formación vocacional**.
1940-1959	Ruth A. Robinson · Margaret Rood	Robinson (coronel): programas educativos de TO en el **ejército**. Rood (TO y física): pionera del **control motor**, reflejos, técnicas de **facilitación e inhibición**.
1960-1979	Mary Reilly · A. Jean Ayres	Reilly (Centro Neuropsiquiátrico de Los Ángeles): marco conceptual con **visión holística** del individuo y sus ocupaciones. Ayres: evaluación del **procesamiento sensorial**.
1960-1979	Gail Fidler · Ann Mosey	Fidler: ocupación como **expresión emocional** (teoría interpersonal, autoestima, teoría del yo). Mosey: sobre Fidler, marco referencial con objetos y conceptos integrales.
1980-1999	Florence Clark · Gary Kielhofner	Clark: los humanos como **seres ocupacionales**; programas de **estilos de vida** para prevenir el deterioro cognitivo. Kielhofner: sumó a Reilly el individuo guiado por **volición, habituación y desempeño**.
2000-presente	Carolyn Baum · Wilcock y Townsend	Baum (presidenta AOTA): **"Visión del Milenio"**, metas al 2017 (investigación y liderazgo). Wilcock y Townsend: **justicia ocupacional**; la oportunidad de ocupación como requisito de salud (2004).

1.2 Objeto de estudio y bases filosóficas

OBJETO DE LA CO (CARRASCO Y OLIVARES, 2008)

El **conocimiento sobre el objeto de la terapia ocupacional profesional**. Debe basarse en una **perspectiva posmoderna** de la ciencia que, por su complejidad, incorpore una **variedad de métodos**.

La filosofía como marco

Es una red de **supuestos** (ideas o principios) y **creencias** (convicciones de lo que es verdadero). Las 7 bases de la CO: **pragmatismo** · movimiento de **artes y oficios** · **Iluminismo** europeo · **estructuralismo** · **existencialismo** · **humanismo** · **holismo**.

PREMISA CENTRAL DE LA TO (SCHELL, SCAFFA Y GILLEN, 2016)

Los seres humanos **cambian constantemente**, están **interconectados con sus entornos** siempre cambiantes, ocupan el tiempo con ocupaciones en constante cambio y, así, **transforman y son transformados** por sus acciones, entornos y condiciones de salud.

1.3 La CO como ciencia social: génesis ocupacional

1917
la **Sociedad para la Promoción de la TO** ve la necesidad de una ciencia que introduzca la ocupación como **medida terapéutica** y estudie su efecto

→

Década del 80
fundación de la CO como **ciencia formal** (elementos teóricos y filosóficos): empieza la investigación científica

→

USC, 1989
meta: una **base sistemática** que describa y entienda la participación en ocupaciones

→

Zemke y Clark, 1996
estudio de la **forma, función y significado**; rol crítico de la ocupación en la salud

¿Por qué es ciencia?

Porque tiene **procesos sistemáticos de recolección de datos** para generar conocimiento.

¿Por qué multiprofesional?

Integra diversos saberes y, al centrarse en el comportamiento humano, es afín a la **antropología, la psicología y la sociología**.

Objetivo principal

Estudiar al **sujeto como ser ocupacional**: cómo comprende el sentido de la vida a través de la actividad orientada a objetivos. Su utilidad: **nutrir a la TO**.

NO CONFUNDIR

La CO nutre a la TO pero **no es un marco de referencia**: es una **ciencia social básica**, con una forma parecida a la antropología o la sociología. Algunos autores la ven como ciencia básica porque aborda temas **universales** de la ocupación, más allá de la TO.

REPASO RÁPIDO

Da Silva Araújo et al. (2011): la CO nace con la profesión. **1917** = necesidad. **80s** = ciencia formal. **Ciencia** = sistemática. **Multiprofesional** = varias ciencias sociales. Análisis del comportamiento humano (USC 1989, citado por Carlson y Clark, 1991).

U2 Evolución histórica de la CO: los períodos de Bing (1981)

Con fines pedagógicos, **Robert K. Bing (1981)** dividió en períodos los eventos que influyeron en el desarrollo del conocimiento de la CO. Para cada uno conviene saber **el contexto** y **las implicancias para la CO**.

1700-1899 "Prehistórico": **Iluminismo** y **tratamiento moral**.

1900-1919 Era **Progresista**, 1.ª Guerra, **1917** Barton.

1920-1939 Gran Depresión, **Meyer**, medicalización.

1940-1959 2.ª Guerra, rehabilitación, **Bobath**, Rood.

1960-1979 Derechos civiles, **Reilly** y **Ayres**.

1980-1999 Vietnam, internet, TC y RM, licencias.

2000-hoy Terrorismo, globalización, era digital.

Período	Contexto	Implicancias en la CO
1700-1899 Iluminismo	Uso del **pensamiento lógico**; líderes europeos fortalecen sus naciones apoyando artes y ciencias; se busca el **progreso y la tolerancia** y terminar con el abuso de la Iglesia y el Estado.	Filosofía con **esencia moral** muy fuerte (Bing). Tratamientos más humanos; los "insanos" como **seres pensantes**. **Tratamiento moral** (para enfermedad mental y física): salud y enfermedad como parte del carácter y el desarrollo espiritual. Impulsó **comunidades terapéuticas**, el compromiso grupal y los servicios sociales.
1900-1919 Era Progresista	Tras la asunción de **Theodore Roosevelt**: reformas a favor de trabajadores y consumidores, leyes **antimonopolio**, optimismo por la innovación. Taft y Wilson: regulación del comercio, financiamiento de la 1.ª Guerra, diplomacia.	**John Dewey** impulsa reformas en educación y salud mental (por los informes de Beers). 1920: **voto femenino**. La Gran Guerra (1914-1918) deja **7 millones de soldados** con lesiones discapacitantes → plan de **"reconstrucción"** (rehabilitación y reeducación vocacional). **1917**: Barton forma la **Society for the Promotion of OT**; nace el puesto de **auxiliar**. La demanda de auxiliares globaliza el puesto y crea la **AOTA** → se **legitima la profesión**.
1920-1939	**18.ª enmienda** (prohibición del alcohol → mercado negro). "Deslumbrantes años veinte": industria, transporte, comunicación, mejores salarios, **sociedad consumista**. 1929: **Gran Depresión** (especulación; **25% de desocupación**). 1932: **F. D. Roosevelt**: seguridad social, impuesto a las ganancias, control de servicios, planes para desempleados y trabajo rural, obras de construcción.	**Dunton** preside la National OT Society y estandariza la educación. Se adopta la **psicobiología de Meyer**: el TO **reorganiza los hábitos diarios**. En la 5.ª reunión de la AOTA: las ocupaciones **previenen la depresión** y aumentan la confianza. Se oponen las teorías de **Freud**; aparecen electroshock y lobotomía. La TO se alinea con la **medicalización** para legitimarse (**Krusen**: medicina física y rehabilitación).
1940-1959	**2.ª Guerra Mundial**: escasez de mano de obra → las **mujeres** entran a la fuerza laboral; falta personal en hospitales; nuevas enfermedades (hepatitis, fiebre reumática, lesiones, químicos). Ley de salud pública y **Ley de Salud Mental (Truman)**; leyes de **rehabilitación vocacional (1943 y 1954)**. Posguerra: crecimiento, pero 36 millones de pobres; énfasis en necesidades sociales; los antipsicóticos impulsan la **desinstitucionalización**.	Influyen los líderes de TO del **ejército** y quienes trabajan con **parálisis motoras**. **Karl y Berta Bobath** (fisioterapeutas): tratamiento del **neurodesarrollo** para parálisis cerebral, luego extendido a otros trastornos. **Robinson**: programas educativos en el ejército. **Rood**: control motor, facilitación e inhibición.
1960-1979	**Derechos civiles**: discurso de **Martin Luther King (1963)** → ley de derechos civiles (**1964**): voto, educación, empleo. Desinstitucionalización → salud mental comunitaria; ley de educación para niños con discapacidad.	**Mary Reilly**: el uso del cuerpo influye en la salud → marco de referencia del **comportamiento ocupacional** (importancia de la **productividad**). **Jean Ayres**: batería de tests de **"integración sensorial y praxis"**. **Mayor desarrollo de la profesión**: terapias sensomotoras desde el neurodesarrollo.
1980-1999	Por la guerra de **Vietnam** se amplían las leyes de salud para personas con discapacidad y los derechos civiles. **Ordenador e internet**. **Tomografía computada y resonancia magnética**.	Aumenta la **demanda de terapeutas** → **ley del presupuesto equilibrado** para regular licencias y certificar el trabajo; programas académicos; impulso a la práctica y la teoría.
2000-hoy	**Terrorismo**, **globalización**, **tecnologías digitales**, **desequilibrio económico**.	Crecimiento **global** por las tecnologías digitales → adaptación de la CO a distintas culturas y contextos. **Regulaciones federales** que ajustan costo y práctica.

⚠ ATENCIÓN

El período **"prehistórico"** de Bing (1700-1899) no es la prehistoria de la humanidad: es la **era del Iluminismo**. No lo confundas con el **período de la magia** (660 a. C.) de los antecedentes de la TO (U5).

⇆ MEYER VS. FREUD

Meyer (psicobiología): enfermedad mental = **desorganización de hábitos** → reorganizar rutinas. **Freud**: teorías psicológicas que en los años 20-30 toman fuerza y se **oponen** a Meyer.

U3 Aproximación conceptual a las ciencias de la ocupación

PUNTO DE PARTIDA (DEMICHELIS Y MEDICCI, 2015)

"Vestirse, ir a una fiesta, arreglar el jardín, ver TV, hacer el amor y preparar comida son ocupaciones. Esto sugiere que los seres humanos **no están preprogramados** para realizar un plan de actividades." Cada día **decidimos** qué hacer: nos despertamos, nos arreglamos, desayunamos, trotamos o vamos a trabajar. Creamos nuestra experiencia diaria **planificando, coordinando y participando** en ocupaciones.

El término **ocupación** suele vincularse con **actividad, tarea, empleo y trabajo**. El ejemplo de la **jardinería** muestra cómo se diferencia:

Tarea
la niña pequeña: "es una **tarea**" (obligación de los adultos)

→

Conocimiento
aprende herramientas y fauna de manera informal: **conjunto de reglas y técnicas** para hacer una actividad

→

Forma, función, significado
de joven ya no es obligación: cumple una **función** distinta, cubrir **necesidades propias**

→

Identidad
de adulta: forma parte de su **identidad**, porque fue una **transacción con el entorno** que perduró en el tiempo

3.1 Evolución del concepto de ocupación

Momento / autor	Qué se plantea
Fundadores de la TO	"Ocupación" = el **tiempo dedicado al trabajo y a actividades recreativas**.
Años 30 hasta 1970	Reina el **reduccionismo**: el concepto de ocupación **está ausente** en el desarrollo de la CO.
1970	Se insta a **reutilizar el término**: su **ambigüedad** permite un tratamiento **holístico** y abre interpretaciones y áreas de práctica.
Nelson (1988)	**Forma ocupacional**: estructura que **preexiste** y que produce, guía o estructura el desempeño posterior. **Desempeño ocupacional**: acciones tomadas **en respuesta** a una forma ocupacional.
Definición posterior	"**Trozos de actividad cotidiana**" iniciados por la persona, con **propósito** y **socialmente sancionados** (tienen nombre en la cultura). Aceptada, pero poco desarrollada por **faltarle el contexto ambiental**.
Canadá (1998)	Grupo de actividades y tareas cotidianas **denominadas, organizadas, con valor y con significado** dado por los individuos y la cultura: todo lo que hacemos para ocuparnos de nosotros mismos: **autocuidado, ocio y productividad**.
Zemke y Clark (1996) · Jackson et al. (1998)	Conjunto de actividades con **significado personal y cultural**. "**Empresas dinámicas**" que pueden **transformar a la persona, el contexto, el tiempo y el orden sociocultural**; producto de interrelaciones entre contexto, experiencias simbólicas y cultura. Las ocupaciones ocurren en un contexto, pero **las personas las modifican**.
Hocking (2000)	Marco de referencia en **3 categorías**: **elementos esenciales** de la ocupación, **procesos ocupacionales** y **relación con otros fenómenos**.
Yerxa et al. (1998)	Actividad **identificada por la cultura**, con **propósito**, en un **tiempo determinado**.
Clark y Lawlor (2009)	Se destaca la relación **actividad, participación y salud**: cómo la participación y las estructuras sociales permiten y exigen salud, calidad de vida y experiencia humana.

3.2 Relación entre la CO y la TO

TO interdisciplinaria
La TO es un **saber y una práctica interdisciplinaria**: sus teóricos buscan en otras ciencias modelos que justifiquen su objeto (Demichelis y Medicci, 2015).

Kielhofner y Burke (1985)
Interdisciplinariedad en la teoría del **comportamiento ocupacional**: tomaron la **biología** y la **teoría general de sistemas** y elaboraron el **modelo de la ocupación humana**.

USC (1989)
CO = estudio sistemático del hombre como **ser ocupacional** que destaca sus potencialidades. Ocupación = **fragmentos de actividad** personal **culturalmente significativa**.

PROTOOCUPACIONES

Las ocupaciones humanas requieren **autoconciencia**, recordar, **proyectar** y elaborar **significados** personales y culturales. Los animales buscan alimento y siguen estímulos, pero sus actividades están **ligadas al presente** y tienen poco **contenido simbólico**: son **protoocupaciones**. La diferencia es el **contenido simbólico**.

QUÉ ESTUDIA HOY LA CO

La **forma, función, significado** y los **contextos históricos y socioculturales** de las ocupaciones: hace falta una perspectiva **multidimensional**, organizable por la **TGS (Von Bertalanffy, 1968)**. Busca superar las **cadenas causales simples** y estudiar normas, convicciones morales, significados simbólicos, respuestas emocionales y contextos.

DATO DE INVESTIGACIÓN

Las **experiencias de cada día** afectan el bienestar psicológico **más que los grandes eventos** de la vida y pueden ser grandes promotoras de la salud. Además de cómo se adapta la persona a lo largo de la vida, hay que sumar dimensiones de **estructuras y procesos de la organización social**.

U4 Paradigmas emergentes de la CO y la TO

Al principio el concepto de ocupación no se consideraba, pero **Kielhofner y Burke (1977)** plantean que el **paradigma fundador** fue la **perspectiva ocupacional** centrada en las personas y su salud en la vida diaria.

Preparadigma de la ocupación
2.ª Revolución Industrial y 1.ª Guerra. Eje: **la ocupación**. Se consolida en **1917** (National Society for the Promotion of OT)

→

Paradigma mecanicista
2.ª Guerra, auge **neopositivista** y reduccionista; TO dentro de la **medicina**. Eje: **la función**

→

Paradigma de la ocupación
2.ª revolución científica (Modernidad-Posmodernidad): del neopositivismo al **interpretacionismo**. Eje: la **ocupación humana**

→

Paradigma social de la ocupación
la ocupación como fenómeno **social** y sistémico, dentro del **paradigma de la complejidad**

Preparadigma: sus fundamentos

Inicio epistemológico de la TO basado en la **filosofía pragmatista**, el **tratamiento moral** y el movimiento de **artes y oficios**. Se oponían a las visiones de su época: el **fundamentalismo teórico**, la **discriminación de clases y desigualdad** y la **industrialización** (Morrison, Olivares y Vidal, 2011).

Mecanicista: qué cambia

Por el contexto social, político, cultural y sobre todo **económico**, la TO busca asentarse en las **ciencias biomédicas**: queda **determinada por la medicina**, con técnicas **paliativas** para reducir incapacidad, centrada en sistemas biológicos e intrapsíquicos. Se estudian los sistemas **neuromotor y musculoesquelético**; con las neurociencias surge la **integración sensorial** en niños (**Jean Ayres**). Lo holístico se reduce a **mente-cuerpo**, con foco en la acción refleja y la función motora.

Paradigma de la ocupación

Exige nuevos enfoques para responder a la salud y calidad de vida. **Kielhofner y Burke (1977)**, propulsores del modelo de ocupación humana: la TO debe fundamentarse como **ciencia aplicada**. La ocupación se ve como fenómeno **individual y subjetivo** y **complejo**.

Paradigma social (el actual)

La ocupación **no es solo individual**: es un fenómeno **sistémico, complejo, económico, político, sanitario, cultural, social** y coherente con la **justicia y el bienestar de las comunidades**. Está inserto en un nivel de abstracción mayor: el **paradigma de la complejidad**.

ACTIVIDAD DE REPASO DE LA LECTURA

"Kielhofner y Burke plantean, **en 1988**, el paradigma fundador de la CO" → **Falso** (es **1977**). "El nuevo paradigma de la TO está sostenido por el paradigma de la complejidad a nivel contextual" → **Verdadero**.

OCUPACIÓN VS. FUNCIÓN

En el **preparadigma** y en el **paradigma de la ocupación**, el eje es la **ocupación**. En el **mecanicista**, la ocupación deja de ser el eje y lo reemplaza la **función**.

U5 Antecedentes históricos de la TO y de la CO

Usando los períodos del módulo 1, ahora el foco está en los **antecedentes que llevaron a la TO** tal como la conocemos hoy, con datos de **Argentina**.

Período de la magia (660 a. C.)

Primeras referencias a actividades como **sanación**. **Cornelius Celsus** recomendaba practicar **vela, correr, cazar, juegos de pelota, lectura en voz alta**, adecuados al **temperamento** de la persona.

Tribus precolombinas

Pensamiento **mágico**: la locura tiene causas sobrenaturales; rituales de cura. Los **quechuas** distinguían melancolía, delirio, embriaguez. Con pócimas, mímicas y conjuros se buscaba extraer los espíritus malignos: era el trabajo de las **"machis"**.

Aborígenes (abipones)

Más cerca del futuro **tratamiento moral**: curaban con el **baile**. Ante un melancólico en frenesí (Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco) se impedía lastimarlo y la **familia lo acompañaba** compartiendo actividades de abastecimiento y ejercicio.

AÑO 1100: UN FRENO

Aparecen las primeras **universidades europeas**: el impulso de la ocupación como medida terapéutica se **frena** por el creciente interés en la **anatomía, la fisiología y la psicología**.

ARGENTINA

Primer hospital de Buenos Aires (~**1610**) con el primer **Cuadro de dementes**, luego trasladado al Hospital General de Hombres (medida higiénica). Con el **protomedicato** crece el interés por lo psiquiátrico y se acerca a la **doctrina pineliana** (trato humano, ocupación y actividad para la salud) → **tratamiento moral (1732-1822)**. En **1899** surge un asilo público, pero el exceso de pacientes, la falta de médicos y la economía lo alejan del tratamiento moral.

Período	Antecedentes de la TO
1900-1919	En **1917** las actividades del tratamiento moral se conjugan en el centro de convalecencia y hogar de **George Edward Barton**. Al entrar EE. UU. en la guerra ya había programas de formación de trabajadores de la ocupación (enfermeras, ONG, casas de acogida), impulsados por la reforma de salud mental, las lesiones físicas, la tuberculosis y las bajas de guerra. El director de Salud Pública estandariza cursos: nacen los **auxiliares de reconstrucción**, que trabajaban con pacientes **ortopédicos y psiquiátricos** mediante **oficios**.

Período	Antecedentes de la TO
1920-1939	Domina la **reconstrucción de soldados** (Quiroga, 1995); TO con empleo en esos centros y en hospitales psiquiátricos. La **AOTA** genera **redes**, asambleas y publicaciones que validan la profesión (Dunton, 1925). **Eleanor Clarke Slagle** promueve a la **mujer** mediante redes en clubes de mujeres. En **1929** hay **19 asociaciones** de TO. En **1935**, la asociación con la **American Medical Association** lleva a la **medicalización** (predomina la rehabilitación física). Recién con la epidemia de **polio y tuberculosis (pico en 1952)** se retoman terapias lúdicas y vocacionales.
1940-1959	Influyen los líderes militares de la TO y quienes trabajan con parálisis motoras. Se desarrolla el **NDT** (tratamiento del neurodesarrollo): primero para **parálisis cerebral**, luego para deficiencias neurológicas y trastornos del desarrollo. Combina técnicas médicas (control de patrones de tono y movimiento) con técnicas de TO (intervenciones **lúdicas** y en **contextos naturales**). Programas educativos de TO para el **ejército**.
1960-1979	Comisión de Terapistas inglesa liderada por **Anne Ricket** (formación clínica; asignaciones de la Comisión Nacional de Rehabilitación). Argentina: el **Instituto Nacional de Salud Mental** (luego Dirección Nacional) contribuye a la rehabilitación social; el **Dr. García Badaracco** crea el **Hospital de Día del Hospital Borda** con TO egresados de la **Escuela Nacional de TO** → validación del título. Cuando caducan las designaciones, se crea un **servicio central de TO** con trabajos artesanales. Mundo: en **1964** la AOTA impulsa la ciencia y se expande en la **American Occupational Therapy Foundation**; **licencias** estatales. Teoría de la **integración sensorial** (holismo mente-cuerpo, enfoques ascendentes). Ley de educación para niños con discapacidad (**1975**), **Medicare y Medicaid** → más TO en el sistema educativo.
1980-1999	Atención a la **salud pública**; reforma de **Clinton** debatida por la industria privada de seguros. Se impulsa la investigación, la eficacia y el **alcance de la práctica** para diferenciarse de otras profesiones. **1986**: la AOTA separa la **certificación** de la membresía (por la legislación antimonopolio). **1990**: ley **ADA** contra la discriminación de personas con discapacidad (empleo, servicios públicos, transporte, telecomunicaciones).
2000-hoy	Presión sobre la **calidad** de los tratamientos y su vínculo con la investigación médica. Enfoque **basado en la población**: **prevención y promoción**, enfermedades crónicas, más edades. Revisión de modelos con perspectivas culturales → primera reunión de la **Sociedad para el estudio de la ocupación**. En **2010**: **27%** intervención temprana, **28%** atención hospitalaria, **16%** rehabilitación a largo plazo y **7%** salud comunitaria.

U6 La TO basada en la ciencia de la ocupación

¿QUÉ ES LA CO?

Surge en las **ciencias sociales** como ciencia **interdisciplinaria** sostenida por la **sociología, la antropología, la filosofía y la psicología** (Clark y Lawlor, 2009). Deriva de los principios de la TO, que **nace como accionar profesional** y **después** busca bases teóricas que la validen. No se limita a la TO: amplía la mirada del ser **biopsicosocial** a la **dimensión ocupacional**.

Del 1917 al 1980

La "Sociedad para la Promoción de la TO" busca desde **1917** una ciencia que una práctica y teoría (Rudman et al., 2008); culmina en **1980**. **Yerxa (1967)**: el primer paso para profesionalizar una práctica es un **cuerpo de conocimiento sustentado por la investigación**.

Ocupación (RAE)

Acción y efecto de ocupar u ocuparse; trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa; trabajo, empleo, oficio, actividad, entretenimiento.

≈

Actividad (RAE)

Facultad de obrar; prontitud en el obrar; diligencia, eficacia; conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

La RAE los define **prácticamente como sinónimos**; la CO los diferencia y, además de la actividad, incluye a **todos los actores sociales** que participan en ocupaciones en sus contextos sociales, culturales e históricos (interrelación **actividad-participación-salud**).

6.1 Cómo investiga la CO

Carlson y Clark (1991)

Metodología **cualitativa y cuantitativa**, para entender la ocupación desde todos los ángulos. Base: el análisis del comportamiento humano (USC, 1989).

Métodos no tradicionales

Historias de vida, **narrativas**, **etnografías** y **aproximaciones fenomenológicas**, junto con las metodologías de las ciencias duras. Perspectiva **posmoderna** (Álvarez et al., 2007).

Retroalimentación

Clark y Lawlor (2009): se ampliaron las preguntas y los métodos. La investigación **básica y aplicada** fortalecen y retroalimentan a la CO y a la TO.

Autores para asociar

Parham (1998): la **naturaleza ocupacional del ser humano** como principal metodología de investigación de la TO. Emmons, Diener y Larsen (1986), Rodin y Langer (1977): efecto de las actividades cotidianas sobre la **salud, la felicidad y la satisfacción**. **Clark et al. (1997)**: el desafío de la TO es **documentar la efectividad** de sus tratamientos, y la CO viene a resolverlo. **Wilcock (1999)**: la ocupación como base de la TO, útil para **todas las personas**, no solo para quienes necesitan asistencia médica.

LA FORTALEZA DE LA RELACIÓN

Un **cuerpo de conocimientos cuyo foco es la ocupación**, que da soporte y enriquece la práctica de la TO. Como la ocupación es **objeto y herramienta** del TO, este necesita conocimiento científico para validarse ante la comunidad científica y la población.

6.2 CO y TO: en qué se diferencian

Ciencia de la ocupación
Disciplina académica. Noción del ser humano: **ser ocupacional**, con preguntas sobre la **forma, función y significado** de la ocupación y cómo generamos significado a través de ella. Campo: articula saberes de la CO y la práctica de la TO; dimensiones existenciales, **construcción simbólica** en cada cultura y repercusiones en salud y sociedad (Clark, Wood y Larson, 2002).

vs

Terapia ocupacional
Profesión. Nace del **hacer** (accionar profesional) y luego busca su sustento teórico. Usa la ocupación como **objeto y herramienta** de intervención. Ambas se focalizan en la ocupación.

En común: concepción biomédica (Miralles y Ayuso, 2004)
Tres aspectos: **1) organismo** (estructuras y funciones corporales), **2) actividad** (capacidad de desempeñar actividades), **3) participación** social. Un problema de salud involucra las tres.

Goldstein (1997)
La relación TO-CO genera un modelo donde las identidades individuales de la TO se vinculan con la CO y organismos internacionales → **identidad global** de la profesión, adaptable a cada **cultura**. Hoy la CO es una ciencia **principalmente práctica**: busca **soluciones** a necesidades de salud y participación.

U7 Aplicaciones de la CO y la TO

La CO **nutre y se retroalimenta** de la TO y fortalece su base de conocimientos, ajustada a las demandas **personales, culturales y temporales** de cada sujeto.

a) Necesidades corporales
Alimentación, protección, autocuidado y seguridad.

b) Habilidades y estructuras
Desarrollo de habilidades, estructuras sociales y tecnologías que garanticen la seguridad y la supervivencia.

c) Ejercer capacidades
Ejercer la capacidad y las habilidades personales para el mantenimiento y desarrollo del organismo.

↑ Los **tres propósitos básicos de la ocupación** según **Wilcock (1993)**. La ocupación es la herramienta con la que el TO estructura la intervención en muchos campos.

SALUD MENTAL: ANTES Y DESPUÉS
Antes, la TO era la encargada de **cuidar el ocio** de los pacientes, calmar los conflictos de los patios y cuidar a las personas. Se **revalorizó** con las propuestas de **reinserción social y laboral**, que potencian el vínculo entre usuario, familia, equipo de salud y comunidad.

SALUD PREVENTIVA
Programas de **rediseño de vida**: reorganizar las **rutinas diarias** puede **reducir la morbilidad** y los efectos de la discapacidad.

Dimensión ecológica de la salud (Wilcock, 1993)
Relaciones sanas entre personas, organismos vivos, ambientes, hábitos y modos de vida: vitales para la salud a largo plazo. No hace falta **dañar el ambiente** para desplegar el potencial de ser, hacer y ocuparse. Los **gobiernos** deberían mantener ambientes naturales que desafíen el potencial de las personas.

⚠ CUIDADO CON LA LÓGICA DE LA AUTOGESTIÓN
Los programas deben considerar lo local y lo global. Hoy la lógica gubernamental promueve la **autogestión y autorregulación**: **individualiza responsabilidades** y achica el rol del **Estado** como garante. Hay que considerar el **acceso a materiales** y **evitar penalizar** a quien no se ajusta cuando no tuvo las **condiciones materiales** para hacerlo.

EL DESAFÍO DE TRADUCIR (CLARK Y LAWLOR, 2009)
La CO aporta a otras disciplinas más allá de la TO. El desafío es **traducir las necesidades del otro** y proponer **puntos de paso** entre disciplinas, con un **desarrollo local** que atienda las necesidades socioculturales reales. Hay que reconocer nuestras propias **"tecnologías semióticas"** para construir significados y versiones fidedignas de un mundo parcialmente compartido.

U8 TO tradicional vs. TO basada en la CO: modelos de diversidad funcional

Los acontecimientos de los últimos 70 años dieron distintos **modelos de la diversidad funcional**, que marcan cómo se mira el accionar profesional y a las personas que reciben TO (Palacios y Romañach, 2006). (La lectura dice "tres tipos", pero desarrolla **cinco**.)

Modelo	Causa de la diversidad	Respuesta y rasgos
1. Prescindencia	**Castigo divino** (religiosa)	La sociedad **prescinde** de las personas: políticas **eugenésicas**, marginación o relegación a la **caridad**.
2. Médico-rehabilitador	**Científica**: salud o enfermedad (ya no Dios o el diablo)	Empieza tras la **1.ª Guerra** (mutilados); auge al final de la **2.ª**. Pueden aportar a la comunidad **solo si se rehabilitan**: **rentabilidad social** condicionada a asimilarse a los "válidos y capaces" (García, 2003). Diferencia **a erradicar**; psicología de la rehabilitación; **educación especial**; **institucionalización**; mirada **paternalista, asistencialista y caritativa**. Experimentos **nazis**. Los avances médicos aumentaron la supervivencia y la población con diversidad funcional.

Modelo	Causa de la diversidad	Respuesta y rasgos
3. Vida independiente / social	**Social**: limitaciones de la sociedad para prestar servicios adecuados	Fines de los **60** y principios de los **70** en **EE. UU. e Inglaterra**, junto a feminismo, derechos de las personas negras y críticas a Vietnam. El **MVI** (**Ed Roberts**) busca empoderamiento, **desmedicalización y desinstitucionalización**, decidir y elegir la forma de vida, apoyo entre iguales, sin barreras arquitectónicas, **diseño universal**, ayudas técnicas, vivienda y empleo. En los 80 llega a Europa (Gran Bretaña, Suecia). Se **rehabilita a la sociedad**, no a la persona. Principios: **vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y diálogo civil**. Toda vida es igualmente digna; inclusión = **igualdad de oportunidades**.
4. Capacidades	Enfoque de **Martha Nussbaum**	Cada capacidad es sustento de la **dignidad humana**; una vida sin posibilidad de ejercer alguna no es plenamente humana. Si algunas no están al alcance (p. ej., diversidad intelectual), su vida **igual es humana** y la **sociedad** debe acercarle cuantas capacidades sea posible mediante una **tutela adecuada**.
5. Diversidad	Nace en **2006** (Foro de Vida Independiente)	Evolución del modelo social. Responde a sus límites: no daba soluciones para quienes **"no pueden"**, ni a los problemas **bioéticos**, ni a la plena transversalidad. El eje deja de ser la capacidad y pasa a ser la **dignidad**; no se habla de normalidad sino de **diversidad** (funcional, cultural, religiosa, sexual, de género, étnica, de edad...). Herramientas: **Derechos Humanos y Bioética**.

Principio 1
La **diversidad** es un **valor inherente** a la humanidad: las personas con diversidad funcional son parte del colectivo de diferentes que la enriquecen.

Principio 2
Todas las personas, con o sin diversidad funcional, tienen la **misma dignidad**.

Principio 3: dos dignidades
Intrínseca: el **valor de la vida**, igual para todos. **Extrínseca**: los **derechos y condiciones de vida**; dotar de entorno, herramientas y posibilidades para vivir en las mismas condiciones que los demás.

⇆ MÉDICO VS. SOCIAL
Médico-rehabilitador: el problema está en la **persona** → se la rehabilita/normaliza. **Social**: el problema está en la **sociedad** → se rehabilita/normaliza la sociedad para que responda a las necesidades de todos.

⇆ CAPACIDADES VS. DIVERSIDAD
Capacidades (Nussbaum): el eje es la **capacidad** como sustento de la dignidad. **Diversidad** (2006): el eje es directamente la **dignidad** (intrínseca y extrínseca), incluso para quien no tiene "ninguna capacidad".

Para consultar: autores y conceptos clave

Autor	Asociá con...	Concepto	En una línea
Townsend (1997)	Ocupación = proceso activo de vivir	Tratamiento moral	Trato humano y ocupación para la salud mental
Tracy y Clark	Ocupación importante para la salud	Auxiliares de reconstrucción	Primeros "TO" con soldados (oficios)
Pinel · Tuke	Precursor · padre del tratamiento moral	Medicalización	TO alineada con la medicina (AMA 1935)
Beers (1908)	Movimiento de salud mental	Forma ocupacional	Estructura previa que guía el desempeño
Meyer	Psicobiología: hábitos desorganizados	Protoocupaciones	Actividades animales sin contenido simbólico
Dunton · Slagle · Barton	Programas 1912 · ocupaciones curativas · Sociedad 1917	Paradigma mecanicista	Eje en la función; TO subordinada a la medicina
Rood · Bobath	Control motor · neurodesarrollo (NDT)	Paradigma social	Ocupación como fenómeno social y complejo
Reilly · Ayres	Comportamiento ocupacional · integración sensorial	Concepción biomédica	Organismo, actividad, participación
Fidler · Mosey	Ocupación como expresión emocional · marco referencial	Rediseño de vida	Reorganizar rutinas para prevenir
Kielhofner (y Burke)	Volición, habituación, desempeño; MOHO; paradigma 1977	Dimensión ecológica	Relación sana persona-ambiente-hábitos
Wilcock y Townsend	Justicia ocupacional (2004)	Tecnologías semióticas	Cómo construimos significados
Bing (1981)	Períodos históricos de la CO	MVI	Ed Roberts; base del modelo social

Autor	Asociá con...	Concepto	En una línea
Carrasco y Olivares (2008)	Objeto de la CO, perspectiva posmoderna	Dignidad intrínseca	Valor de la vida
Nelson (1988)	Forma y desempeño ocupacional	Dignidad extrínseca	Derechos y condiciones de vida
Hocking (2000)	Tres categorías de conocimiento	Justicia ocupacional	Oportunidades de ocupación para la salud
Carlson y Clark (1991)	Métodos cualitativos y cuantitativos	Ley ADA (1990)	Antidiscriminación por discapacidad
Palacios y Romañach (2006)	Modelos de diversidad funcional		

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

Para practicar en voz alta o por escrito. La respuesta modelo marca lo mínimo que no puede faltar.

¿Por qué se dice que el conocimiento de la CO no se desarrolló de forma lineal?

Porque se gestó según el **contexto**: industrialización, derechos de la mujer, guerras, crisis económicas, leyes de salud y era digital. Ej.: la 1.ª Guerra creó la necesidad de auxiliares (1917); la AMA (1935) la medicalizó; la 2.ª Guerra trajo el paradigma mecanicista.

Explicá qué es la CO y en qué se diferencia de la TO.

Es una **ciencia social básica**, interdisciplinaria y multiprofesional que estudia al ser humano como **ser ocupacional** (forma, función y significado). La TO es una **profesión** que nace del hacer y usa la ocupación como objeto y herramienta. La CO **nutre** a la TO, pero no es un marco de referencia.

Describí la evolución de los paradigmas.

Preparadigma (pragmatismo, tratamiento moral, artes y oficios; eje: ocupación; 1917) → **mecanicista** (2.ª Guerra, neopositivismo, medicina; eje: función) → **paradigma de la ocupación** (interpretacionismo; Kielhofner y Burke) → **paradigma social** (fenómeno social y complejo, justicia y bienestar comunitario, dentro del paradigma de la complejidad).

Usá el ejemplo de la jardinería para explicar el concepto de ocupación.

Para la niña es una **tarea**; al hacerla aprende reglas y técnicas (**conocimiento**); de joven cumple una **función** propia (forma, función, significado); de adulta es parte de su **identidad** por ser una transacción con el entorno sostenida en el tiempo.

¿Qué cambió en la TO en el período 1920-1939?

Contexto: 18.ª enmienda, años 20, Gran Depresión (25% de desocupación), reformas de F. D. Roosevelt. En la TO: Dunton estandariza la educación, se adopta la **psicobiología de Meyer** (reorganizar hábitos), Freud se opone, y la TO se **medicaliza** para legitimarse (Krusen; AMA 1935).

Compará el modelo médico-rehabilitador con el social.

Médico: causas científicas, el problema está en la persona, se la rehabilita para que sea "rentable"; institucionalización y paternalismo. **Social**: causas sociales (MVI, Ed Roberts, años 60-70), se rehabilita a la sociedad; vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno y diálogo civil.

¿Qué aporta el modelo de la diversidad respecto de los anteriores?

Nace en 2006 como evolución del social. Responde a quienes "no pueden" y a los problemas bioéticos. Cambia el eje de la capacidad a la **dignidad** (intrínseca: valor de la vida; extrínseca: derechos y condiciones). Herramientas: **DD. HH. y Bioética**.

¿Cuáles son los propósitos de la ocupación y cómo se aplican hoy?

Wilcock (1993): necesidades corporales; habilidades, estructuras sociales y tecnologías; ejercer capacidades. Se aplican en salud mental (reinserción social y laboral), en prevención (**rediseño de vida**) y con una mirada **ecológica** de la salud, atenta a no penalizar a quien no tiene las condiciones materiales.

Preparación para el parcial

1 Ubicá el período
Si te dan un hecho (Gran Depresión, Truman, MLK), pensá qué pasó en la CO en ese mismo período.

2 Autor + palabra clave
Meyer = hábitos. Rood = facilitación e inhibición. Ayres = integración sensorial. Reilly = comportamiento ocupacional.

3 ¿Cuál es el eje?
En los paradigmas, preguntate si el eje es la ocupación, la función o la ocupación como fenómeno social.

4 Fechas que se preguntan
1917 Sociedad · 1935 AMA · década del 80 CO formal · 1989 USC · 2006 modelo de la diversidad.

5 ¿Dónde está el problema?
Persona = médico-rehabilitador. Sociedad = social. Dignidad = diversidad.

6 CO ≠ TO
Disciplina académica vs. profesión. Si dice "ciencia social básica", es la CO.

Errores frecuentes

- ⊗ *"Pinel es el padre del tratamiento moral."* → Fue **precursor**; el padre es **William Tuke**.
- ⊗ *"La CO es un marco de referencia de la TO."* → Es una **ciencia social básica** que la nutre.
- ⊗ *"El paradigma fundador es de 1988."* → Kielhofner y Burke lo plantean en **1977**.
- ⊗ *"En el mecanicista el eje es la ocupación."* → Es la **función**.
- ⊗ *"Meyer y Freud coincidían."* → Las teorías de Freud se **oponían** a la psicobiología de Meyer.
- ⊗ *"Forma ocupacional = acciones de la persona."* → Eso es **desempeño**; la forma es la **estructura previa**.
- ⊗ *"El modelo social rehabilita a la persona."* → Rehabilita a la **sociedad**.
- ⊗ *"Cuidar el ocio es un propósito de Wilcock."* → Los 3 son necesidades corporales, habilidades/estructuras y ejercer capacidades.

Tarjetas de memoria rápida

7 bases filosóficas
Pragmatismo, artes y oficios, Iluminismo, estructuralismo, existencialismo, humanismo, holismo.

CO es ciencia porque...
Recolecta datos sistemáticamente; es multiprofesional.

Jardinería
Tarea → conocimiento → forma, función, significado → identidad.

Canadá 1998
Denominadas, organizadas, con valor, con significado.

Hocking 2000
Elementos esenciales, procesos, relación con otros fenómenos.

Paradigmas
Preparadigma → mecanicista → ocupación → social.

Preparadigma
Pragmatismo + tratamiento moral + artes y oficios.

Kielhofner
Volición, habituación, desempeño.

Wilcock 1993
Necesidades corporales, habilidades y estructuras, ejercer capacidades.

Biomédica
Organismo, actividad, participación.

Métodos no tradicionales
Historias de vida, narrativas, etnografías, fenomenología.

2010
27% temprana, 28% hospital, 16% rehab., 7% comunidad.

5 modelos
Prescindencia, médico, social, capacidades, diversidad.

Principios sociales
Vida independiente, no discriminación, accesibilidad, normalización del entorno, diálogo civil.

Dignidad
Intrínseca (vida) y extrínseca (derechos).

Argentina
1610 Cuadro de dementes · Badaracco: Hospital de Día del Borda.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
"Una mente que se encontró a sí misma"	**Beers** (salud mental)	Flexner (educación médica)
Cura por el trabajo y artesanías (neurastenia)	**Hall**	Barton (tuberculosis, parálisis histérica)
Iluminismo, trato humano	**1700-1899 (Bing)**	Período de la magia (660 a. C.)
Estructura previa que guía	**Forma ocupacional**	Desempeño ocupacional
Actividades animales	**Protoocupaciones**	Ocupaciones (con contenido simbólico)
Ed Roberts	**MVI → modelo social**	Modelo de la diversidad (2006)
Rentabilidad social tras rehabilitarse	**Médico-rehabilitador**	Capacidades (Nussbaum)
Derechos y condiciones de vida	**Dignidad extrínseca**	Dignidad intrínseca (valor de la vida)

S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

1 **¿Quién definió la ocupación como "el proceso activo de vivir, desde el comienzo hasta el final de la vida"?**

Ⓐ Kielhofner.
Ⓑ Townsend (1997).
Ⓒ Nelson (1988).
Ⓓ Hocking (2000).

2 **¿A quién se considera el padre del movimiento del tratamiento moral?**

Ⓐ Philippe Pinel.
Ⓑ John Locke.
Ⓒ Adolf Meyer.
Ⓓ William Tuke.

3 **El escrito de Clifford Beers *Una mente que se encontró a sí misma* (1908) llevó a:**

Ⓐ La creación del movimiento de salud mental.
Ⓑ La reforma de la educación médica.
Ⓒ El tratamiento del neurodesarrollo.
Ⓓ La fundación de la AOTA en 1964.

4 **Según la psicobiología de Adolf Meyer, la enfermedad mental es:**

Ⓐ El resultado de conflictos inconscientes.
Ⓑ Una lesión del sistema nervioso.
Ⓒ Un reflejo de la desorganización de los hábitos de vida.
Ⓓ Un castigo divino.

5 **¿Qué agregó Kielhofner al trabajo de Mary Reilly?**

Ⓐ La teoría de la integración sensorial.
Ⓑ El individuo como ser ocupacional guiado por volición, habituación y desempeño.
Ⓒ El concepto de justicia ocupacional.
Ⓓ Las técnicas de facilitación e inhibición.

6 **El concepto de "justicia ocupacional" fue desarrollado por:**

Ⓐ Ann Wilcock y Elizabeth Townsend.
Ⓑ Carolyn Baum.
Ⓒ Mary Reilly.
Ⓓ Gail Fidler.

7 **Según Carrasco y Olivares (2008), el objeto de la CO es:**

Ⓐ La función de los sistemas biológicos.
Ⓑ La rehabilitación física de los pacientes.
Ⓒ Solo el trabajo remunerado.
Ⓓ El conocimiento sobre el objeto de la TO profesional, desde una perspectiva posmoderna con variedad de métodos.

8 **¿Cuándo se funda la CO como ciencia formal, con elementos teóricos y filosóficos?**

Ⓐ En 1917.
Ⓑ En 1935.
Ⓒ En la década del ochenta.
Ⓓ En 2006.

9 **¿Por qué se considera que la CO es una ciencia?**

Ⓐ Porque tiene procesos sistemáticos de recolección de datos para generar conocimiento.
Ⓑ Porque es un marco de referencia clínico.
Ⓒ Porque depende de la medicina.
Ⓓ Porque solo usa métodos cuantitativos.

10 **La división de la historia de la CO en períodos (1700-1899, 1900-1919, etc.) con fines pedagógicos se debe a:**

Ⓐ Quiroga (1995).
Ⓑ Robert K. Bing (1981).
Ⓒ Kielhofner y Burke (1977).
Ⓓ Palacios y Romañach (2006).

11 **En 1917, la Society for the Promotion of Occupational Therapy se conforma gracias a:**

Ⓐ William Rush Dunton Jr.
Ⓑ Eleanor Clarke Slagle.
Ⓒ George Edward Barton.
Ⓓ Frank H. Krusen.

12 **Entre 1920 y 1939 la TO se alinea con la medicalización. ¿Quién tuvo gran impacto al desarrollar la medicina física y rehabilitación?**

Ⓐ Sigmund Freud.
Ⓑ John Dewey.
Ⓒ Ruth A. Robinson.
Ⓓ Frank H. Krusen.

13 **Margaret Rood se destacó por:**

Ⓐ La integración sensorial y praxis.
Ⓑ La teoría del control motor y las técnicas de facilitación e inhibición.
Ⓒ La ocupación como expresión emocional.
Ⓓ El marco del comportamiento ocupacional.

14 **La batería de tests de "integración sensorial y praxis" la desarrolló:**

Ⓐ Jean Ayres.
Ⓑ Mary Reilly.
Ⓒ Ann Mosey.
Ⓓ Karl y Berta Bobath.

15 **En el ejemplo de la jardinería, ¿qué se denomina "conocimiento"?**

Ⓐ La obligación impuesta por los adultos.
Ⓑ La identidad que adquiere de adulta.
Ⓒ El conjunto de reglas y técnicas para llevar a cabo una actividad.
Ⓓ El significado cultural de la actividad.

16 **Para Nelson (1988), la "forma ocupacional" es:**

Ⓐ Las acciones que se toman en respuesta a una ocupación.
Ⓑ El tiempo dedicado al trabajo y la recreación.
Ⓒ Un fragmento de actividad sin contexto.
Ⓓ La estructura que preexiste y guía el desempeño humano posterior.

17 **La definición canadiense de 1998 caracteriza a las ocupaciones como actividades y tareas:**

Ⓐ Denominadas, organizadas, con valor y con significado.
Ⓑ Remuneradas, obligatorias y productivas.
Ⓒ Individuales, biológicas y reflejas.
Ⓓ Preprogramadas y universales.

18 **La CO llama "protoocupaciones" a:**

Ⓐ Las ocupaciones de los niños pequeños.
Ⓑ Las ocupaciones anteriores a 1917.
Ⓒ Las actividades de los animales, ligadas al presente y con poco contenido simbólico.
Ⓓ Las tareas obligatorias.

19 **En el paradigma mecanicista, el eje central de la TO pasa a ser:**

Ⓐ La ocupación humana.
Ⓑ La función.
Ⓒ La justicia ocupacional.
Ⓓ El tratamiento moral.

20 **El paradigma actual concibe la ocupación como fenómeno sistémico, social y político. Se llama:**

Ⓐ Preparadigma de la ocupación.
Ⓑ Paradigma mecanicista.
Ⓒ Paradigma neopositivista.
Ⓓ Paradigma social de la ocupación, dentro del paradigma de la complejidad.

21 **Cornelius Celsus recomendaba vela, correr, cazar y juegos de pelota según el temperamento. Esto corresponde a:**

Ⓐ El tratamiento moral.
Ⓑ La Era Progresista.
Ⓒ El período de la magia (660 a. C.).
Ⓓ El modelo médico-rehabilitador.

22 **Los "auxiliares de reconstrucción" eran:**

Ⓐ Personas capacitadas que trabajaban con pacientes ortopédicos y psiquiátricos mediante oficios.
Ⓑ Médicos militares especializados en cirugía.
Ⓒ Arquitectos que adaptaban hospitales.
Ⓓ Enfermeras de la Segunda Guerra.

23 **La asociación con la American Medical Association en 1935 llevó a:**

Ⓐ La desinstitucionalización.
Ⓑ La medicalización de la TO, con predominio de la rehabilitación física.
Ⓒ La creación del modelo social.
Ⓓ La ley ADA.

24 **En Argentina, el Dr. García Badaracco creó:**

Ⓐ El primer Cuadro de dementes.
Ⓑ El protomedicato.
Ⓒ La Escuela Nacional de TO.
Ⓓ El Hospital de Día del Hospital Borda.

25 **La metodología que proponen Carlson y Clark (1991) para estudiar la ocupación es:**

Ⓐ Cualitativa y cuantitativa.
Ⓑ Solo experimental.
Ⓒ Solo cualitativa.
Ⓓ Exclusivamente biomédica.

26 **¿Cuál es la diferencia básica entre la CO y la TO?**

Ⓐ La CO estudia la función y la TO la ocupación.
Ⓑ No hay diferencias.
Ⓒ La CO es una disciplina académica y la TO, una profesión.
Ⓓ La TO es anterior a cualquier ocupación terapéutica.

27 **Los tres aspectos de la concepción biomédica (Miralles y Ayuso, 2004) son:**

Ⓐ Volición, habituación y desempeño.
Ⓑ Organismo, actividad y participación.
Ⓒ Forma, función y significado.
Ⓓ Persona, entorno y tarea.

28 **¿Cuál NO es uno de los tres propósitos básicos de la ocupación según Wilcock (1993)?**

Ⓐ Satisfacer necesidades corporales.
Ⓑ Desarrollar habilidades, estructuras sociales y tecnologías.
Ⓒ Ejercer capacidades para mantener y desarrollar el organismo.
Ⓓ Cuidar el ocio de los pacientes.

29 **"Causas científicas, rentabilidad social si la persona se rehabilita e institucionalización" describe al modelo:**

Ⓐ De prescindencia.
Ⓑ Social.
Ⓒ Médico-rehabilitador.
Ⓓ De la diversidad.

30 **En el modelo de la diversidad (2006), el punto central es:**

Ⓐ La capacidad.
Ⓑ La dignidad (intrínseca y extrínseca), con DD. HH. y Bioética como herramientas.
Ⓒ La normalidad.
Ⓓ La rehabilitación individual.

✎ TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	B	A	D	C	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	B	A	C	D	A	C	B	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	A	B	D	A	C	B	D	C	B

1. B) Es la definición de Townsend (1997). × C: forma/desempeño. D: tres categorías. A: volición, habituación, desempeño.

2. D) Tuke es el padre; Pinel fue precursor. × B: aprendizaje sensorial y pragmatismo. C: psicobiología.

3. A) Beers critica los asilos y nace el movimiento de salud mental. × B: Flexner. C: Bobath. D: no tiene relación.

4. C) Para Meyer, los hábitos desorganizados → reorganizar rutinas. × A: Freud. D: modelo de prescindencia.

5. B) Kielhofner suma el ser ocupacional con volición, habituación y desempeño. × A: Ayres. C: Wilcock y Townsend. D: Rood.

6. A) Wilcock y Townsend (2004): justicia ocupacional. × B: Visión del Milenio. C: holismo. D: expresión emocional.

7. D) Definición textual de Carrasco y Olivares. × A y B describen el paradigma mecanicista; C es demasiado restrictiva.

8. C) La CO como ciencia formal aparece en los 80. × A: se ve la necesidad. B: AMA. D: modelo de la diversidad.

9. A) Es ciencia por recolectar datos sistemáticamente. × B: no es marco de referencia. D: usa métodos cuali y cuanti.

10. B) Bing (1981) periodizó con fines pedagógicos. × A: primeros 30 años. C: paradigma fundador. D: modelos de diversidad.

11. C) Barton conjuga la Sociedad en 1917 y crea el puesto de auxiliar. × A: programas 1912. B: ocupaciones curativas. D: rehabilitación.

12. D) Krusen: medicina física y rehabilitación. × A: se opone a Meyer. B: Era Progresista. C: ejército (40-59).

13. B) Rood: control motor, facilitación e inhibición. × A: Ayres. C: Fidler. D: Reilly.

14. A) Ayres creó la batería de integración sensorial y praxis. × D: neurodesarrollo (NDT).

15. C) Conocimiento = reglas y técnicas para hacer la actividad. × A: tarea. B: identidad. D: significado.

16. D) La forma ocupacional es la estructura previa. × A: eso es desempeño ocupacional. B: definición de los fundadores.

17. A) Canadá 1998: denominadas, organizadas, con valor y significado. × D: los humanos no están preprogramados.

18. C) Protoocupaciones = actividades animales con poco contenido simbólico. × A, B y D no son lo que dice el texto.

19. B) En el mecanicista la ocupación deja de ser el eje y lo es la función. × A: preparadigma y paradigma de la ocupación.

20. D) Paradigma social, dentro del de la complejidad. × B y C: reduccionistas.

21. C) Celsus pertenece al período de la magia. × A: siglo XVIII-XIX. B: 1900-1919.

22. A) Auxiliares: capacitados, trabajaban con oficios. × B, C y D: otras figuras.

23. B) Medicalización con predominio de la rehabilitación física. × A: 40-50s. C: 60-70s. D: 1990.

24. D) Badaracco crea el Hospital de Día del Borda. × A: ~1610. C: de allí egresaban los TO.

25. A) Carlson y Clark: cuali + cuanti. × B, C y D recortan la propuesta.

26. C) CO = disciplina académica; TO = profesión. × A: ambas se focalizan en la ocupación.

27. B) Organismo, actividad, participación. × A: Kielhofner. C: CO (Zemke y Clark). D: modelos ecológicos (M4).

28. D) Cuidar el ocio era el rol antiguo de la TO en salud mental. × A, B y C sí son los 3 propósitos.

29. C) Médico-rehabilitador. × A: castigo divino. B: causas sociales. D: dignidad.

30. B) El eje es la dignidad. × A: Nussbaum. C: se reemplaza por diversidad. D: médico.